Cochez la ou les réponse (s) juste (s) et reportez-les sur la grille

1. A propos du médicament :

A. Un seul principe actif peut avoir plusieurs noms commerciaux.

B. La dénomination commune internationale (DCI) est attribuée à un seul principe actif.

C. Les médicaments de Liste I sont les stupéfiants.

D. Les médicaments non listés sont accessibles sans ordonnances.

E. Les médicaments magistraux sont préparés à l'avance, le plus souvent au niveau d'un laboratoire pharmaceutique industriel.

2. Parmi les effets suivants, quels sont ceux qui représentent l'action de l'organisme sur les médicaments ?

A. Le passage d'un principe actif, pris par voie orale, du milieu digestif vers les vaisseaux sanguins.

B. Fixation des principes actifs sur les récepteurs endogènes.

C. Modification de la structure des principes actifs par des réactions enzymatiques.

D. Déclenchement d'un effet indésirable suite à l'administration d'un principe actif.

E. Excrétion des produits de dégradation du principe actif hors l'organisme.

3. En ce qui concerne les champs d'application de la pharmacologie :

A. La pharmacovigilance, s'occupe uniquement de la surveillance du potentiel addictif des médicaments.

B. La pharmacogénétique détecte la variation des effets ou de la cinétique des médicaments en fonction des caractéristiques génétiques de l'individu.

C. La pharmaco-économie traite la caractérisation de l'utilisation des médicaments dans les différentes populations ou groupes sociaux.

D. La pharmacologie sociale étudie l'impact des médicaments et des substances sur les individus et sur la société dans son ensemble.

E. Les études de pharmacovigilance permettent d'évaluer les médicaments dans les conditions réelles d'utilisation.

4. A propos des formes pharmaceutiques :

A. Une forme pharmaceutique est une association principe(s) actif(s) (PA) avec ou sans excipient(s).

B. Il existe deux formes pharmaceutiques : liquide et solide seulement.

C. Les capsules molles sont dites encore des gélules.

D. Les gélules sont des capsules dures.

E. La poudre n'est pas une forme pharmaceutique.

5. Parmi ces préparations, laquelle n'est pas semi-solide ?

A. Gels.

B. Pommades.

C. Poudre.

D. Crème.

E. Pâte.

6. À propos des excipients :

A. Ils sont toujours responsables de l'effet thérapeutique.

B. Ils sont appelés encore adjuvants.

C. Les excipients à effet notoire ne peuvent jamais présenter un risque d'allergies et /ou d'intolérance.

D. Ils aident à concevoir la forme galénique.

E. Ils aident à libérer le PA de sa forme pharmaceutique.

7. Les voies avec effraction cutanéo- muqueuse type vasculaires sont :

A. Intra-veineuse.

B. Intramusculaire.

C. Intra-artérielle.

D. Sous cutanée.

E. Intra-cardiaque.

8. Parmi ces voies d'administration sans effractions cutanéo –muqueuses, lesquelles sont utilisées en thérapeutique pour une visée générale ?

A. Cutanée.

B. Oculaire.

C. Vaginale.

D. Rectale.

E. Pulmonaire.

9. La voie d'administration intraveineuse :

A. Présente une biodisponibilité faible.

B. Est une voie d'administration traumatisante.

C. Evite l'effet de premier passage hépatique uniquement.

D. Est une voie d'urgence.

E. Peut présenter un risque infectieux.

10. Concernant la pharmacocinétique des médicaments :

A. Elle étudie l'action du médicament sur l'organisme.
B. Elle comporte toujours la phase d'absorption.
C. Dans les voies à visée locale, la phase de distribution n'est pas nécessaire.
D. Elle étudie le devenir du médicament dans l'organisme.
E. Elle est identique pour tous les médicaments.

11. Parmi les facteurs suivants, quels sont ceux qui peuvent influencer l'absorption sublinguale des médicaments ?

A. La taille de la molécule.
B. La forme galénique.
C. Les pansements gastriques.
D. La glycoprotéine P.
E. Le transit intestinal.

12. Concernant l'effet de la glycoprotéine P sur l'absorption :

A. Elle diminue la quantité de médicaments substrats administrés par voie sublinguale.
B. Elle diminue la quantité de médicaments non substrats administrés par voie orale.
C. Elle augmente la quantité de médicaments substrats administré par voie rectale.
D. Les inhibiteurs de cette glycoprotéine P augmentent l'absorption des médicaments substrats.
E. Les inhibiteurs de cette glycoprotéine P n'ont pas d'influence sur les médicaments administrés par voie intraveineuse.

13. Par quelles voies d'administration le médicament ne subit pas d'effet de premier passage hépatique ?

A. Voie orale.
B. Voie rectale.
C. Voie sublinguale.
D. Voie intraveineuse.
E. Voie intra-musculaire.

14. Parmi les propositions suivantes relatives à la fixation des molécules aux protéines plasmatiques, quelles sont celles qui sont exactes?

A. Les protéines circulantes concernées sont l'albumine, l'α1 -glycoprotéine acide, des γ-globulines et des lipoprotéines.
B. La liaison des médicaments aux protéines plasmatiques est toujours irréversible.
C. Le Furosémide est un médicament fortement fixés aux protéines plasmatiques.
D. La warfarine est un médicament faiblement fixés aux protéines plasmatiques.
E. La capacité de fixation d'une protéine dépend du nombre de sites (n) disponibles par mole de protéine et de la concentration molaire en protéine.

15. A propos de la diffusion tissulaire des médicaments :

A. Seule la forme libre peut diffuser aux différents tissus de l'organisme.
B. La liposolubilité est un facteur limitant la diffusion tissulaire.
C. Les molécules hydrosolubles diffusent facilement à travers la barrière hémato-encéphalique.
D. La diffusion des molécules à travers la barrière fœto-placentaire est assurée uniquement par diffusion active.
E. Certains tissus peuvent devenir un réservoir des molécules, comme le tissu adipeux.

16. Une molécule est qualifiée d'avoir une bonne distribution si :

A. Elle a une forte liaison aux protéines plasmatiques.
B. Sa liposolubilité est importante.
C. Elle a une Forte proportion de forme non ionisée.
D. Elle concerne des tissus ou des organes faiblement irrigués.
E. Elle a une forte affinité pour les tissus.

17. Les facteurs influençant la vitesse de métabolisation des médicaments sont :

A. L'âge.
B. L'allaitement.
C. L'insuffisance cardiaque.
D. L'insuffisance hépatique.
E. Les facteurs génétiques.

18. Les réactions métaboliques de phase I sont :

A. La glucuro-conjugaison.
B. L'oxydation.
C. L'acétylation.
D. L'hydrolyse.
E. La sulfoconjugaison.

19. Un métabolite issu de la phase II :

A. Est généralement actif.
B. Est généralement polaire.
C. Nécessite toujours une réaction préalable de phase I.
D. Peut être éliminé par les urines.
E. Peut subir un cycle entéro-hépatique.

20. Quelles sont les caractéristiques de l'élimination par sécrétion tubulaire ?

A. Se fait selon le gradient de concentration.
B. Nécessite un apport d'énergie.
C. Ne nécessite pas la présence de transporteurs.
D. Il peut y avoir un phénomène de compétition.
E. Le processus de transport peut être saturé.

actif

⊖ → ⊕

21. A propos de la réabsorption tubulaire :

A. C'est le passage d'une molécule de la lumière tubulaire du néphron vers le sang.

B. Les acides très faibles non ionisés au pH urinaire ne sont jamais réabsorbés.

C. Dans une urine acide, les acides sont moins ionisés et donc moins réabsorbés.

D. Dans une urine alcaline, les acides sont plus ionisés et donc plus réabsorbés.

E. Les bases fortes ionisées totalement au pH urinaire ne sont jamais réabsorbées.

22. Concernant la sécrétion biliaire :

A. Elle est d'autant plus importante que la molécule présente une grande polarité.

B. Les médicaments sécrétés activement peuvent entrer en compétition avec le transport actif de la bilirubine.

C. L'élimination par cette voie est majorée en cas d'insuffisance hépatique.

D. Les médicaments au poids moléculaire < 300 Da peuvent subir le cycle entéro-hépatique.

E. Le temps de demi-vie du médicament est réduit s'il subit le cycle entéro-hépatique.

23. Le modèle bicompartimental par voie intraveineuse (IV) comporte :

A. Une phase d'absorption.

B. Une phase de distribution.

C. Une phase d'élimination.

D. Une cinétique mono-phasique.

E. Une courbe descendante après administration d'une dose unique de médicaments.

24. Un patient était bien équilibré sous une dose de 100 mg de morphine par voie IV. Quelle sera la dose nécessaire à administrer par voie sous-cutanée sachant que sa biodisponibilité par cette voie est la moitié de celle de la voie IV ?

A. 50 mg.

B. 200mg.

C. 150 mg.

D. 250mg.

E. 300 mg.

25. Quels paramètres pharmacocinétiques permettent d'estimer le cumul d'un médicament ?

A. La concentration minimale (Cmin).

B. La concentration maximale (Cmax).

C. La surface sous la courbe (AUC).

D. Le volume de distribution (Vd).

E. La constante d'absorption.

26. A propos des récepteurs membranaires

A. Les récepteurs membranaires couplés à la protéines G sont formés de deux éléments : le récepteur + la protéine G.

B. Les récepteurs d'activité cationique sont dits inhibiteurs.

C. Le récepteur de l'insuline est un récepteur enzyme.

D. Les récepteurs GABA-A sont des récepteurs à activité anionique.

E. Les récepteurs nicotiniques sont des récepteurs à activité anionique.

27. Parmi les molécules suivantes, quelles sont celles qui ont des récepteurs nucléaires ?

A. La vitamine D

B. L'insuline.

C. L'acétylcholine.

D. Les hormones stéroïdiennes.

E. L'histamine.

28. Concernant les incompatibilités physico-chimiques :

A. Ce sont des réactions physico-chimiques entre deux médicaments à l'intérieur de l'organisme.

B. Elles peuvent être des réaction physico-chimique entre un médicament et certains liquides de perfusion.

C. Elles peuvent concerner l'association d'un médicament acide et basique dans une même seringue.

D. Elles peuvent entrainer des précipités toxiques.

E. Leurs conséquences ne sont jamais invisibles.

29. Concernant les interactions pharmacocinétiques au niveau de la phase d'absorption :

A. Elles ne sont jamais gérables.

B. La co-administration d'un anti-acide avec un médicament acide faible nécessite généralement d'espacer les prises entre eux d'au moins 2 heures.

C. La co-administration d'un inhibiteur de glycoprotéine P avec un médicament substrat nécessite généralement d'espacer les prises entre eux d'au moins 2 heures.

D. Il est préférable d'éviter de boire du lait juste après la prise du fer (risque de complexation).

E. La prise d'aliments n'a jamais de conséquence sur l'absorption des médicaments.

30. Au cours du suivi thérapeutique de la ciclosporine (médicament substrat de la glycoprotéine P et métabolisé par le cytochrome CYP3A), on remarque une augmentation de la concentration plasmatique. Quelles sont les causes possibles ?

A. Association avec un inhibiteur du CYP 2D6.

B. Association avec du jus de pamplemousse.

C. Arrêt de l'inducteur du CYP 3A.

D. Association avec un inhibiteur du CYP 3A.

E. Association avec un inducteur de la glycoprotéine P.

31. Concernant l'antagonisme compétitif irréversible :

A. Il se fait via des récepteurs différents.
B. Il n'est pas surmontable par augmentation de la concentration de l'agoniste.
C. L'affinité de l'agoniste pour son récepteur peut etre modifiée.
D. Les Médicaments A et B ont une action sur la même fonction physiologique mais en sens inverse.
E. Il entraine une augmentation de l'effet thérapeutique de l'agoniste.

32. A propos des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) :

A. Les effets indésirables digestifs sont secondaires à une diminution de la synthèse des prostaglandines.
B. Les effets indésirables digestifs sont secondaires à la prise des AINS au milieu des repas.
C. Constituent le traitement de choix de la fièvre secondaire à la varicelle.
D. Améliorent la perfusion rénale.
E. Peuvent être responsable d'une photosensibilisation.

33. A propos des corticoïdes :

A. Il faut les administrer le matin.
B. Il faut les administrer le soir.
C. En cas de traitement prolongé, l'arrêt doit être progressif.
D. Lors d'une dose élevée donner le 1/3 de dose le matin et les 2/3 le soir à 22h.
E. Lors d'une dose élevée donner toute la dose le soir.

34. L'essai clinique de phase I d'un médicament :

A. Est réalisé chez le volontaire sain à l'exclusion des médicaments anticancéreux.
B. Inclut un nombre très important de volontaires malades.
C. Est effectué sans étude animale préalable.
D. Comprend les toutes premières administrations chez l'homme.
E. Inclut les études de pharmacocinétique.

35. Concernant un essai clinique de phase III ?

A. Il vise à déterminer la Dose Maximale Tolérée « DMT ».
B. Il est comparatif à un traitement de référence ou à un placebo.
C. Son objectif principal est de prouver l'efficacité du produit.
D. Correspond aux études post AMM.
E. Cherche à détecter les effets secondaires très rares.

36. Concernant les essais cliniques :

A. Dans les essais en ouvert, le malade ne doit pas savoir qu'il est inclus dans un essai clinique.
B. L'investigateur peut être pharmacien, médecin, infirmier.
C. On parle d'essai en double insu lorsque le participant et l'investigateur ne connaissent pas la nature des traitements administrés.
D. Un protocole d'essai clinique doit être rédigé avant de débuter l'essai.
E. L'autorisation de mise sur le marché (AMM) est demandée au début de la phase I.

37. A propos de la pharmacovigilance :

A. Seuls les professionnels de la santé peuvent déclarer les effets indésirables des médicaments.
B. Le score de l'imputabilité intrinsèque est obtenu en croisant les scores chronologiques et sémiologiques.
C. La notification se fait grâce à une fiche de déclaration.
D. Il faut déclarer un effet indésirable grave immédiatement après son apparition.
E. L'imputabilité extrinsèque repose sur l'analyse des critères chronologiques et sémiologiques.

38. Concernant la pharmacovigilance :

A. C'est la surveillance des médicaments et la prévention du risque d'événement indésirable résultant de leur utilisation.
B. Elle participe à la lutte contre l'iatrogénie médicamenteuse.
C. Elle est basée seulement sur la notification spontanée.
D. La méthode d'imputabilité la plus utilisée est la méthode française.
E. C'est une étape non indispensable dans l'étude de tout médicament après sa commercialisation.

39. Le Plan de Gestion des Risques « PGR » :

A. Il fait partie du dossier AMM.
B. C'est un outil participant à la surveillance des médicaments.
C. Il est requis pour tout médicament contenant une nouvelle substance active.
D. Il est obligatoire uniquement en cas d'autorisation temporaire d'utilisation « ATU ».
E. Il permet de mieux caractériser ou prévenir les risques associés.

40. Les parasympathomimétiques directs :

A. Stimulent les récepteurs muscariniques.
B. Bloquent l'acétylcholinestérase.
C. Provoquent une mydriase.
D. Peuvent être indiqués dans le traitement du glaucome.
E. Provoquent un bronchospasme.

41. L'intoxication aux organophosphorés peut être traitée par :

A. L'ésérine.
B. La néostigmine.
C. Un parasympathomimétique direct.
D. Un parasympathomimétique indirect.
E. L'atropine

42. Les parasympathomimétiques muscariniques peuvent être indiqués dans le traitement de :

A. Hypertension artérielle « HTA ».
B. Glaucome.
C. Asthme.
D. Ulcère gastrique.
E. Hypersécrétion salivaire.

43. La pyridostigmine :

A. Est liposoluble.
B. Est utilisée dans le traitement de la myasthénie.
C. Traverse la barrière hématoencéphalique.
D. Est utilisée dans le traitement de l'asthme.
E. Est hydrosoluble.

44. Les médicaments anticholinergiques antimuscariniques peuvent entrainer :

A. Une constipation.
B. Un myosis.
C. Une sécheresse buccale.
D. Une augmentation des sécrétions digestives acides.
E. Une bronchoconstriction.

45. Pour traiter un spasme viscéral chez un patient ayant un glaucome à angle étroit il est possible de prescrire :

A. Un antispasmodique mixte.
B. Un antispasmodique musculotrope.
C. Un antispasmodique neurotrope.
D. Un antispasmodique musculotrope en prise simultanée avec le charbon activé.
E. Un antispasmodique neurotrope en prise simultanée avec le charbon activé.

46. Parmi ces effets pharmacologiques, lesquels sont ceux des agonistes bêta adrénergiques ?

A. Tachycardie.
B. Bonchoconstriction.
C. Myorelaxation utérine.
D. Inotropisme négatif.
E. Vasodilatation.

47. Le salbutamol est un médicament:

A. Sympthomimétique direct.
B. Sympatholytique indirect.
C. Bronchodilatateur.
D. Myorelaxant utérin
E. Agoniste α2 adrénergique.

48. L'α-methyl-DOPA est un médicament:

A. Sympathomimétique α1.
B. Sympathomimétique β2.
C. Antihypertenseur central.
D. Pouvant être utilisé chez la femme enceinte.
E. Inhibant la libération de noradrénaline.

49. L'effet rebond est un effet indésirable qui peut survenir suite à :

A. L'instauration de l'α-methylDOPA.
B. L'arret brutal de la clonidine.
C. La recapture de noradrénaline par les neurones présynaptiques.
D. La décharge massive de noradrénaline.
E. L'instauration d'un sympathomimétique direct.

50. Parmi les médicaments suivants ; le(s)quel(s) est(sont) un(des) médicament(s) sympatholytique(s) direct(s):

A. Les bêtabloquants cardiosélectifs.
B. Inhibiteur de la MonoAmine Oxydase (IMAO).
C. Les amphétamines.
D. Les agonistes α1-adrénergiques.
E. Les inhibiteurs de la dégradation des catécholamines.

51. La cardioséléctivité des bêtabloquants leur confère:

A. Une action exclusive β2.
B. Une certaine sécurité chez les malades asthmatiques.
C. Une action β1-mimétique.
D. Une action β1-lytique.
E. Un effet inotrope négatif.

52. Quelles sont les indications des α1-bloquants ?

A. Hypotension orthostatique.
B. Hypertrophie bénigne de la prostate.
C. Dépression.
D. Hypertension artérielle « HTA ».
E. Asthme.

53. A propos de La régulation de la pression artérielle :

A. Les mécanismes de régulation agissent à court et moyen terme seulement.
B. La régulation nerveuse fait intervenir le système kinine kalliKréine.
C. La régulation hormonale fait intervenir le système rénine angiotensine aldostérone.
D. La régulation hormonale fait intervenir l'hormone anti-diurétique.
E. Le monoxyde d'azote est un vasoconstricteur d'origine endothéliale.

54. A propos des diurétiques :

A. Ils diminuent l'élimination urinaire d'eau et de sodium.
B. Ils sont Indiqués dans le traitement des œdèmes.
C. Ils sont classés en fonction de leur effet sur la kaliémie.
D. Les diurétiques thiazidiques sont hyperkaliémiants.
E. Ils peuvent être utilisés en association dans la prise en charge de l'hypertension artérielle.

55. Parmi ces molécules, lesquelles ne sont pas des bétabloquants ?

A. Bisoprolol.
B. Aténolol.
C. Enalapril .
D. Vérapamil.
E. Propranolol.

56. Les antibiotiques :

A. Peuvent être prescrits à un patient sans signes cliniques d'infections.
B. Peuvent être prescrits à un patient avec signes cliniques d'infections sans preuve bactériologique.
C. Sont bactériostatiques si leur CMB est deux fois la CMI.
D. Sont bactériostatiques si leur CMB est quatre fois la CMI.
E. Sont toujours utilisés dans le traitement des infections virales.

57. A propos des antibiotiques :

A. Un antibiotique concentration-dépendant nécessite de préférence une administration journalière continue.
B. Un antibiotique concentration-dépendant nécessite de préférence une administration journalière unique.
C. Un antibiotique temps-dépendant nécessite de préférence une administration rapprochée des doses fractionnées.
D. Les antibiotiques présentent tous un effet post antibiotique.
E. Les antibiotiques sont tous bactéricides.

58. A propos des effets indésirables des antibiotiques :

A. Le red men syndrome contre-indique toute réadministration de l'antibiotique en cause.
B. L'erythromycine en intra-veineux est contre-indiquée en cas d'arythmie.
C. Les fluoroquinolones sont ototoxiques.
D. La rifampicine peut entrainer des troubles hépatiques.
E. L'acide fusidique est néphrotoxique.

59. À propos des médicaments du tableau B :

A. Ce sont des médicaments à vente libre.
B. Le syndrome de sevrage après l'arrêt brutal du traitement caractérise uniquement cette classe.
C. Le syndrome de sevrage après l'arrêt brutal du traitement peut survenir avec d'autres classes.
D. Ils peuvent entrainer une dépendance psychique et physique après un usage prolongé.
E. La majorité des médicaments de ce tableau sont des psychotropes.

60. À propos de l'ordonnance :

A. L'ordonnance doit être illisible pour le patient afin d'éviter l'effet nocebo.
B. Le patient peut obtenir sur sa demande la délivrance d'une nouvelle prescription de médicament du tableau C.
C. Un médecin a le droit de prescrire tous les médicaments disponibles sans restriction.
D. Un pharmacien a le droit de prescrire une ordonnance contenant un bilan biologique.
E. Une sage-femme n'a pas le droit de prescrire les médicaments.

Université d'Oran 1, Faculté de Medecine d'Oran, Département de Medecine

Examen d'Anatomie Pathologique 3eme année

- **Pour toutes les questions répondez par la ou les réponses justes**

61.L'athérosclérose, est définie par l'accumulation des dépôts de cholestérol au niveau de

A. L'intima des artères de gros et moyen calibre
B. L'intima des grosses veines
C. Des coronaires
D. La couche musculaire des veines
E. Des artères des membres inférieur

62.Parmis les facteurs de risques de l'athérosclérose ou peut citer

A. L'âge
B. Le diabète
C. Les facteurs génétiques
D. Une alimentation pauvre en graisses animales et en protéines
E. Le tabac

63.L'examen microscopique d'une paroi artérielle montre une accumulation des macrophages spumeux dans l'intima. Il s'agit de :

A. Pustule
B. Plaque d'athérome
C. Strie lipidique
D. Stéatose
E. Plaque d'athérome calcifiée

64.La plaque d'athérosclérose se complique de

A. Thrombose
B. Anévrysme
C. Rupture
D. Embolie
E. Cancérisation

65.Concernant les prélèvements cytologiques

A. Ils permettent de faire un diagnostic de certitude
B. Ils constituent l'examen de choix pour le dépistage du cancer du col utérin
C. Le prélèvement peut être fixé à l'air
D. Le fixateur de choix est le formol
E. Peut se faire en utilisant une aiguille.

66. L'examen extemporané

A. C'est un examen réalisé en peropératoire
B. Permet de s'assurer de l'exérèse de la totalité de la lésion avec des marges suffisantes
C. Le prélèvement envoyé doit être fixé au formol
D. Les coupes sont réalisées sur prélèvement de tissu frai congelé à -30°C.
E. Permet de guider l'acte chirurgical

67. L'hypertrophie cellulaire

A. Lésion élémentaire cellulaire survenant suite augmentation du métabolisme cellulaire
B. C'est l'augmentation du nombre de cellules dans un tissu
C. Elle s'observe dans les tissus dont les cellules se divisent peu ou pas (rein, muscle).
D. Elle survient par l'augmentation de l'activité mécanique d'un organe ou par augmentation du métabolisme cellulaire
E. Elle est souvent irréversible

68.L'hyperplasie

A. Correspond à l'augmentation de la masse d'un tissu, par augmentation du volume cellulaire
B. Elle accompagne toujours des modifications de l'architecture tissulaire
C. Elle ne concerne que des tissus dont les cellules peuvent se multiplier
D. Elle peut être physiologique : augmentation des glandes mammaires au cours d'une grossesse
E. C'est phénomène réversible. Il régresse lorsque le facteur en cause disparait

69.L'atrophie

A. Lésion élémentaire cellulaire survenant suite à une diminution de l'activité cellulaire
B. Une hypoplasie d'un organe survenant au cours du développement embryonnaire
C. Correspond à la diminution de la masse tissulaire
D. Elle est liée à une destruction des protéines de structures ou des organites intracellulaires
E. Soit par diminution du nombre de cellules fonctionnelles par la nécrose

70.La Dystrophie

A. Désigne toute altération cellulaire ou tissulaire acquise, souvent irréversibles liées à un processus inflammatoire
B. Elle peut être d'origine vasculaire, hormonale, nerveuse ou métabolique
C. Elle correspond à des phénomènes d'adaptation cellulaire
D. Elle permet d'ajuster l'activité de la cellule en fonction des modifications durables que lui impose son nouvel environnement
E. La dystrophie d'un organe peut combiner des lésions inflammatoires et dysplasique

71.La Métaplasie

A. Elle se définie comme une conversion de la forme et de la fonction d'un ensemble de cellules dans un tissu.
B. Elle intéresse essentiellement les épithéliums de revêtements, mais n'épargne pas les autres tissus.
C. A un rôle dans l'installation d'un nouveau type de tissu, plus apte à résister aux stimuli pathologiques.
D. Elle est toujours pathologique
E. Est directe lorsqu'elle se forme par modification de la maturation des cellules souches

72.Concernant la nécrose et l'apoptose

A. Deux modes de mort cellulaire possèdent les mêmes caractéristiques morphologiques
B. L'Apoptose est une mort cellulaire programmée
C. Les deux sont des phénomènes physiologiques actifs
D. La nécrose survient à un stade précis de la maturation terminale d'une cellule
E. L'apoptose joue un rôle essentiel dans le renouvellement des cellules a durée de vie courte

73.La Nécrose cellulaire

A. Est un phénomène passif, et réversible
B. Est essentiellement cytoplasmique, puis nucléaire suite à une agression de la cellule.
C. Elle résulte de l'autolyse enzymatique de l'ensemble de la cellule
D. Les aspects de la nécrose tissulaire sont liés à ceux de la nécrose cellulaire
E. Elle concerne des cellules isolées et non pas des groupes de cellules comme l'apoptose

74.Concernant l'aspect histologique de la Nécrose on peut noter une

A. Pycnose
B. Caryolyse
C. Caryorrhexis
D. Cytoplasme vacuolisé, hydropique ou surcharger en lipides
E. Hyperéosinophilie cytoplasmique

75.La nécrose gangréneuse

A. C'est une nécrose de liquéfaction (nécrose suppurée)
B. C'est une nécrose de coagulation, due à des troubles circulatoires
C. Se caractérise par la combinaison d'une nécrose ischémique et d'une infection le plus souvent à germe anaérobie.
D. Survient lorsque la digestion enzymatique domine, comme dans les infections à pyogènes (staphylocoque..)
E. Le tissu n'est plus reconnaissable.

76.Concernant l'apoptose

A. Elle joue un rôle dans le maintien de l'homéostasie tissulaire
B. Elle assure l'équilibre constant entre mort et prolifération cellulaire
C. Elle concerne des groupes de cellules et non pas des cellules isolées comme la nécrose
D. Elle permet l'élimination sélective de certaines cellules lésées ou tumorales
E. Elle induit toujours une réaction inflammatoire

77.La nécrose calcifiée

A. Constitue une variété relativement tardive de nécrose
B. Les foyers nécrotiques récents ne se calcifient jamais
C. Les calcifications sont fréquentes dans les lésions de nécrose de coagulation récentes
D. Elle ne se voit jamais dans la cytostéatonécrose
E. Constitue une évolution constante de la nécrose caséeuse

78.L'apoptose se déroule en plusieurs phases, lesquelles

A. Synthèse d'enzymes permettant la lyse de la cellule
B. Condensation des organites intracytoplasmiques
C. Perte de cohésion entre les cellules
D. Clivage de l'ADN en nucléosomes aboutissant à la formation de corps apoptotique.
E. Induction d'une réaction inflammatoire

79.Le rejet aigu d'un gréffon hépatique se présente par

A. Des lésions de portite.
B. Une fibrose hépatique.
C. Une cholangite.
D. Une ductopénie.
E. Des lésions d'endothélites

80.Le rejet chronique d'un greffon est reconnu par la présence

A. Des lésions d'endothélite.
B. Des remaniements oedémateux et hémorragiques tissulaires
C. Une fibrose tissulaire
D. Une atrophie des structures épithéliales tissulaires
E. Un épaississement des parois vasculaires.

81.Parmi les signes cliniques suivants lesquels témoignent d'une inflammation aigue

A. Rougeur.
B. Chaleur.
C. Douleur.
D. Fibrose.
E. Tuméfaction.

82.La tuberculose

A. Est liée à une infection par un virus.
B. Peut comporter du caséum.
C. Survient uniquement au niveau des poumons.
D. Est caractérisée par des follicules épitheloides et giganto-cellulaires d'âge identique.
E. L'agent responsable est le mycobacterium tuberculosis.

83.La chéloïde est

A. Une cicatrice cutanée atrophique.
B. Une cicatrice cutanée hypertrophique.
C. Une réparation épithéliale avec absence des structures piloannexielles.
D. Marquée par une disposition anarchique et tourbillonnante des fibres de collagène au niveau du derme.
E. Peut être traitée par les infiltrations aux corticoïdes.

84.Toutes ces tumeurs sont malignes

A. Fibrome
B. B.Ostéosarcome.
C. C.Fibrosarcome.
D. D.Lymphome.
E. E.carcinome epidermoide.

85. Est une tumeur de nature épithéliale

A. Mélanome.
B. Chondrosarcome
C. Carcinome épidermoïde laryngé.
D. Lymhome
E. Ostéosarcome.

86. Parmi les tumeurs suivantes, laquelle (lesquelles) ne donne (nt) pas de métastase

A. Carcinome basocellulaire.
B. Adénome tubuleux ou villeux.
C. Lipome
D. Ostéosarcome.
E. Mélanome.

87. Une tumeur bénigne

A. Est une néoplasie.
B. Ne donne jamais de métastase sauf pour quelques cas exceptionnels.
C. Récidive après exérèse totale.
D. Ressemble à un tissu normal de référence.
E. Se transforme toujours en une tumeur maligne.

88. Toutes ces tumeurs sont d'origine mésenchymateuse

A. Hémangiome.
B. Liposarcome
C. Lymphome malin hodgkinien.
D. Adénocarcinome
E. Carcinome urothelial.

89. Toutes ces tumeurs sont malignes

A. Mélanome.
B. Ostéosarcome.
C. Naevus.
D. Lymphome.
E. Sarcome.

90. Le stroma des cancers

A. Il est de nature conjonctive.
B. Il est dépourvu de vascularisation.
C. C'est un tissu néoformé.
D. Il assure la nutrition des cancers.
E. L'un des défis actuels est d'élaborer des outils pharmacologiques capables d'inhiber la croissance des vaisseaux induite au cours de la croissance tumorale.

91. En pathologie tumorale, l'étude immunohistochimique

A. Est toujours effectuée sur la tumeur primitive, jamais sur les métastases
B. Permet l'identification d'antigènes cellulaires tumoraux.
C. Parfois permet de distinguer les tumeurs malignes des tumeurs bénignes.
D. Aide à l'évaluation de la différenciation d'une tumeur.
E. Peut, dans certains cas, contribuer à prédire la réponse thérapeutique.

92. La métastase

A. Est de même nature que la tumeur primitive.
B. Représente la preuve formelle de la nature maligne d'une tumeur.
C. Seules les tumeurs bénignes donnent de métastases.
D. Le mélanome malin est considéré comme une tumeur maligne hautement métastatique
E. La voie lymphatique est la principale voie de dissémination des carcinomes.

93. La cellule cancéreuse est

A. Le support de la malignité.
B. La base du diagnostic cytologique des cancers
C. Se nourrit du stroma tumoral.
D. Se caractérise par des atypies cyto-nucléaires
E. Possède des anomalies intéressant uniquement le noyau.

94. Les lymphomes peuvent être

A. de phénotype A
B. de phénotype B
C. de phénotype T
D. A grandes cellules
E. A petites cellules

95. Lesquelles parmis ces propositions sont d'origine hématologique

A. Angiome
B. Lymphome à grandes cellules
C. Lymphome de Hodgkin
D. Léomyome
E. Lymphome de Burkitt

96. Parmis ces propositions lesquelles sont des tumeurs glandulaires bénigne ou malignes

A. Adénocarcinome
B. Carcinome mammaire
C. Mélanome
D. Adénome
E. Angiome

97. Les tumeurs germinales

A. Siègent uniquement au niveau des gonades
B. Sont des tumeurs rares
C. Malignes ; elles sont plus fréquentes chez la femme que chez l'homme
D. Elles se développent à partir des cellules germinales primordiales
E. Leur différenciation morphologique est variée, reproduisant des structures observables au cours de l'embryogenèse

98. Seminome

A. Egalement appelé dysgerminome au niveau de l'ovaire
B. Tumeur germinale présentant une similitude morphologique avec les gonies
C. Le pic de fréquence vers 30 ans
D. Tumeur germinale la moins fréquente du testicule
E. Le traitement est basé sur la chirurgie et la radiothérapie rarement la chimiothérapie

99. Les tératomes matures

A. Sont des tumeurs germinales avec une différentiation somatique
B. Très fréquentes au niveau de l'ovaire
C. Sont des tumeurs malignes
D. Souvent appelé « kyste dermoide »
E. Peuvent être simples ou complexes pluritissulaires

100. Les tumeurs du blastème embryonnaire

A. Apparaissent souvent dans l'enfance
B. Leur pronostic dépend de l'âge et du stade de la maladie
C. Parfois deviennent « matures » spontanément ou sous l'effet de la chimiothérapie
D. A l'histologie, les zones blastémateuse indifférenciées sont faites de nappes de petites cellules rondes et bleues
E. Sont bénignes avec une évolution lente

101. Le rétinoblastome

A. Est une tumeur uniquement héréditaire
B. Le gène de la mutation génétique est le RB1
C. Il s'agit d'une tumeur à petites cellules rondes et bleues de type neuroectodermique
D. Le traitement est l'énucléation du globe oculaire, associée à la chimiothérapie ou la radiothérapie selon le bilan d'extension
E. Se développe au niveau de la rétine

102. La matrice extracellulaire

A. Est une trame extracellulaire à laquelle peuvent s'ancrer les cellules
B. Constituée d'une substance fondamentale et de protéines fibreuses
C. Sécrétée par les enzymes MMP matrix métalloprotéinases
D. Assure la résistance des tissus
E. Représente un lieu de diffusion et de stockage des métabolites

103.Dans l'inflammation virale, le pathologiste peut

A. Etablir le diagnostic de certitude sans recours aux techniques virologiques
B. Constater les lésions cellulaires et tissulaires
C. Mettre en évidence les protéines des virions par technique immunohistochimique
D. Mettre en évidence les acides nucléiques viraux par hybridation in situ
E. Evaluer le retentissement tissulaire et cellulaire

104.Parmi les organes suivants pour lequel(lesquels) ; les carcinomes épidermoïdes sont-ils les tumeurs malignes primitives les plus fréquentes

A. Le col utérin
B. Le colon
C. Le pancréas
D. Le larynx
E. L'œsophage

105.Parmi les tumeurs suivantes, lesquelles concernent le revêtement malpighien

A. Un carcinome épidermoïde
B. Un papillome
C. Un adénocarcinome
D. Un carcinome baso-cellulaire
E. Un leiomyosarcome

106. Le cancer peur être secondaire à des facteurs génétiques tel que (s)

A. LE syndrome de Lynch
B. La Xeroderma pigmentosum
C. La polypose recto colique familiale PAF
D. DLe rétinoblastome
E. E.Le cancer du sein lié au gène BRCA1

Cas clinique :

Un enfant de 4 ans, sexe féminin se présente aux urgences pédiatriques pour une douleur abdominale avec HTA chiffrée à 15/ 9, associée à une hématurie ++, sans signes généraux une échographie abdominale a été faite objectivant une masse abdominale solitaire de 10 cm de grand axe d'appartenance rénale.

107. Quel examen radiologique de référence permettant de mieux apprécier les caractéristiques de cette masse ainsi son origine.

A. Une TDM thoracique
B. Une TDM cérébrale
C. Une coloscopie
D. Une TDM abdominale
E. Télé thorax

Les données radiologiques ont montré qu'il s'agit d'une masse rénale droite.

108.Quel est le diagnostic le plus probable chez cet enfant de 4ans

A. Néphroblastome ou tumeur de Wilms
B. Adénocarcinome colique.
C. Tumeur cérébrale
D. Médulloblastome
E. Retinoblastome

109.Sur le plan microscopique, cette tumeur se compose de

A. Cellules fusiformes musculaires lisses.

B. De trois composants : epithelial, blastémateux et stromal.

C. Uniquement de structures glandulaires

D. D'un parenchyme rénal inflammatoire.

E. De lobules carcinomateux de cellules malpighiennes

110.Quelle est la meilleure conduite thérapeutique à suivre pour cette tumeur maligne

A. Traitement symptomatique avec surveillance.

B. Chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie.

C. Traitement chirurgical seul

D. Abstention thérapeutique.

E. Néphrectomie bilatérale.

Code candidat

Nom

Prénom

Date de naissance / /

CORRECTION

Remarques :

Cocher STYLO bleu ou noir, à l'intérieur des Cases
Le crayon n'est pas autorisé

Exemple Si B et D sont justes, cochez par une CROIX :

Q4 :	A	B	C	D	E
	☐	☒	☐	☒	☐

Questions : Pharmacologie de 01 à 60
Questions : Ana-Path de 61 à 110

	A	B	C	D	E
Q1	☒	☒	☐	☒	☐
Q2	☒	☐	☒	☐	☒
Q3	☐	☒	☐	☒	☒
Q4	☒	☐	☐	☒	☐
Q5	☐	☐	☒	☐	☐
Q6	☐	☒	☐	☒	☒
Q7	☒	☐	☒	☐	☒
Q8	☐	☐	☐	☒	☒
Q9	☐	☒	☐	☒	☒
Q10	☐	☐	☒	☒	☐

	A	B	C	D	E
Q31	☐	☒	☒	☐	☐
Q32	☒	☐	☐	☐	☒
Q33	☒	☐	☒	☐	☐
Q34	☒	☐	☐	☒	☒
Q35	☐	☒	☒	☐	☐
Q36	☐	☒	☒	☒	☐
Q37	☐	☒	☒	☒	☐
Q38	☒	☒	☐	☒	☐
Q39	☒	☒	☒	☐	☒
Q40	☒	☐	☐	☒	☒

	A	B	C	D	E
Q61	☒	☐	☒	☐	☒
Q62	☒	☒	☒	☐	☒
Q63	☐	☐	☒	☐	☐
Q64	☒	☒	☒	☒	☐
Q65	☐	☒	☒	☐	☒
Q66	☒	☒	☐	☒	☒
Q67	☒	☐	☒	☒	☐
Q68	☐	☐	☒	☒	☒
Q69	☒	☐	☒	☒	☐
Q70	☐	☒	☒	☒	☐

	A	B	C	D	E
Q91	☐	☒	☒	☒	☒
Q92	☒	☒	☐	☒	☒
Q93	☒	☒	☒	☒	☐
Q94	☐	☒	☒	☒	☒
Q95	☐	☒	☒	☐	☒
Q96	☒	☒	☐	☒	☐
Q97	☐	☒	☐	☒	☒
Q98	☒	☒	☒	☐	☒
Q99	☒	☒	☐	☒	☒
Q100	☒	☒	☒	☒	☐

	A	B	C	D	E
Q11	☒	☒	☐	☐	☐
Q12	☐	☐	☐	☒	☒
Q13	☐	☐	☒	☒	☒
Q14	☒	☐	☒	☐	☒
Q15	☒	☒	☐	☐	☒
Q16	☐	☒	☒	☐	☒
Q17	☒	☐	☒	☒	☒
Q18	☐	☒	☐	☒	☐
Q19	☐	☒	☐	☒	☒
Q20	☐	☒	☐	☒	☒

	A	B	C	D	E
Q41	☐	☐	☐	☐	☒
Q42	☐	☒	☐	☐	☐
Q43	☐	☒	☐	☐	☒
Q44	☒	☐	☒	☐	☐
Q45	☐	☒	☐	☐	☐
Q46	☒	☐	☒	☐	☒
Q47	☒	☐	☒	☒	☐
Q48	☐	☐	☒	☒	☒
Q49	☐	☒	☐	☒	☐
Q50	☒	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
Q71	☒	☒	☒	☐	☐
Q72	☐	☒	☐	☐	☒
Q73	☐	☒	☒	☒	☐
Q74	☒	☒	☒	☒	☐
Q75	☐	☒	☒	☐	☐
Q76	☒	☒	☐	☒	☐
Q77	☒	☒	☐	☐	☐
Q78	☒	☐	☒	☒	☐
Q79	☒	☐	☒	☐	☒
Q80	☐	☐	☒	☒	☒

	A	B	C	D	E
Q101	☐	☒	☒	☒	☒
Q102	☒	☒	☐	☒	☒
Q103	☐	☒	☒	☒	☒
Q104	☒	☐	☐	☒	☒
Q105	☒	☒	☐	☒	☐
Q106	☒	☒	☒	☒	☒
Q107	☐	☐	☐	☒	☐
Q108	☒	☐	☐	☐	☐
Q109	☐	☒	☐	☐	☐
Q110	☐	☒	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
Q21	☒	☐	☐	☐	☒
Q22	☒	☒	☐	☐	☐
Q23	☐	☒	☒	☐	☒
Q24	☐	☒	☐	☐	☐
Q25	☒	☐	☒	☐	☐
Q26	☐	☐	☒	☒	☐
Q27	☒	☐	☐	☒	☐
Q28	☐	☒	☒	☒	☐
Q29	☐	☒	☐	☒	☐
Q30	☐	☒	☒	☒	☐

	A	B	C	D	E
Q51	☐	☒	☐	☒	☒
Q52	☐	☒	☐	☒	☐
Q53	☐	☐	☒	☒	☐
Q54	☐	☒	☒	☐	☒
Q55	☐	☐	☒	☒	☐
Q56	☒	☒	☐	☒	☐
Q57	☐	☒	☒	☐	☐
Q58	☐	☒	☐	☒	☐
Q59	☐	☐	☒	☒	☒
Q60	☐	☒	☐	☒	☐

	A	B	C	D	E
Q81	☒	☒	☒	☐	☒
Q82	☐	☒	☐	☐	☒
Q83	☐	☒	☐	☒	☒
Q84	☐	☒	☒	☒	☒
Q85	☐	☐	☒	☐	☐
Q86	☒	☒	☒	☐	☐
Q87	☒	☒	☐	☒	☐
Q88	☒	☒	☐	☐	☐
Q89	☒	☒	☐	☒	☒
Q90	☒	☐	☒	☒	☒